



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA



Demência · Delirium · Depressão

Saúde do Idoso

Tratamento farmacológico no idoso

Demência, delirium e depressão — do início ao fim

TEMA	Farmacoterapia da demência, do delirium e da depressão no idoso
AUTOR	Prof. Dr. Igor Morais — CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254; Clínica Médica; Cardiologia)
DISCIPLINA	Saúde do Idoso — 9º período
INSTITUIÇÃO	FCMMG — Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais
CARGA HORÁRIA	50 minutos
DATA / VERSÃO	2026 · v1.0

Doses = faixas usuais; individualizar (função renal/hepática, interações, QT) e monitorizar.

Um único idoso pode precisar (ou NÃO) das três classes — e errar a dose custa caro



Foto ilustrativa · CC BY-SA

Sr. P., 79 anos

Alzheimer moderado; humor rebaixado.

Internado por ITU, ficou confuso (delirium).

Usa 7 medicamentos.

Três decisões farmacológicas:



Demência: anticolinesterásico/memantina — indica? dose?



Delirium: prevenir e tratar a causa (ITU) — fármaco é exceção



Depressão: tratar? qual ISRS? o que evitar?



Polifarmácia: o que desprescrever?

O Sr. P. atravessa os 3 blocos — e mostra que “mais remédio” nem sempre é a resposta.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao final, você prescreve as três classes com indicação, dose e segurança



Demência

1

anticolinesterásico, memantina, anti-amiloide:
indicação/dose/limites.



Delirium

2

prevenir 1º; fármaco como exceção; evitar
precipitantes.



Depressão

3

ISRS 1ª linha; o que evitar; duração e
segurança.



Prescrição segura

4

start low/go slow, Beers/STOPP, interações,
desprescrição.



Integrar

5

ciclo:
indicação→escolha→dose→monitorizar→reavalia
r.

Alinhamento construtivo: cada objetivo é cobrado por ≥1 questão no quiz.

Princípios → Demência → Delirium → Depressão → Segurança/desprescrição



Cada bloco segue o mesmo ciclo: indicação → escolha → dose → monitorizar → reavaliar/desprescrever.

“Start low, go slow” — o idoso responde e adoece diferente



Farmacocinética

↓ clearance renal/hepático; ↑ meia-vida; ↑ gordura (lipossolúveis acumulam)



Farmacodinâmica

↑ sensibilidade do SNC (sedação, confusão, quedas, extrapiramidal)



Start low, go slow

menor dose eficaz; titular devagar; um fármaco por vez



Metas realistas

funcionalidade/qualidade de vida; alvo e prazo definidos

Antes de adicionar um fármaco, pergunte: “este sintoma é doença ou é remédio?” (cascata).

Beers e STOPP/START: o que evitar e o que não esquecer



Evitar no idoso (exemplos)

- Benzodiazepínicos (quedas, confusão, dependência)
- Anticolinérgicos (ADT, 1ª-geração anti-H1, oxibutinina)
- Antipsicóticos para BPSD de rotina (black box)
- AINEs crônicos; relaxantes; “Z-drugs”

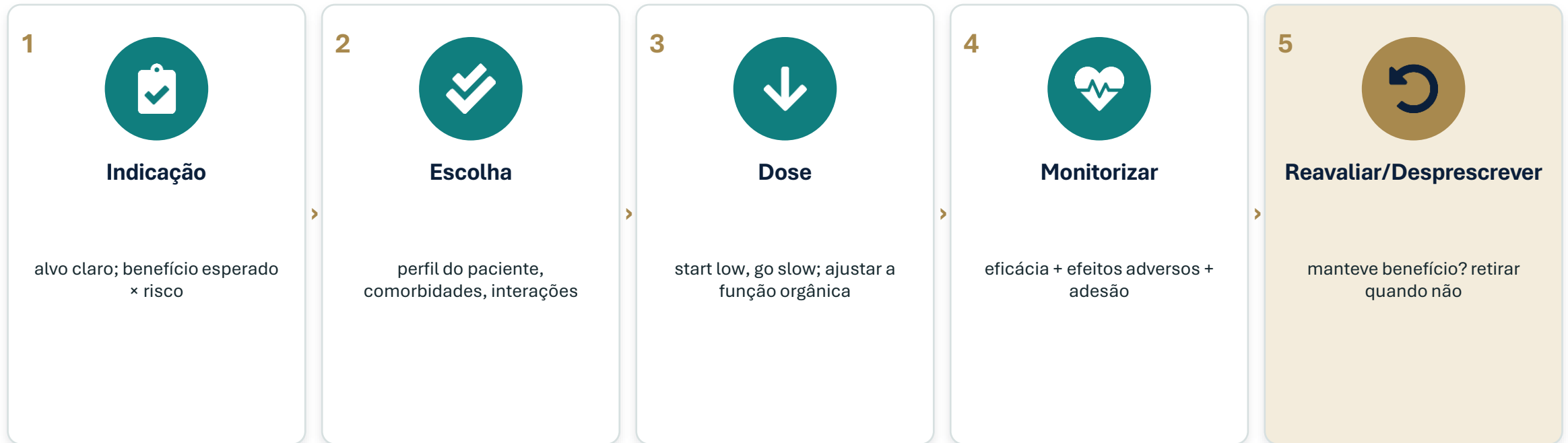


Carga anticolinérgica & START

- Some a CARGA anticolinérgica total (piora cognição/quedas)
- STOPP: suspender o inapropriado
- START: não esquecer o indicado (ex.: tratar depressão, dor)
- Revisar a lista a cada consulta

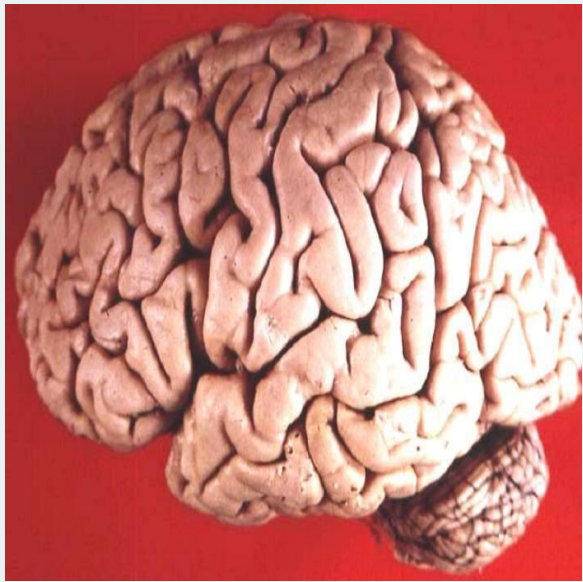
Fonte: AGS Beers Criteria 2023; O'Mahony et al. STOPP/START.

Todo fármaco segue um ciclo — inclusive o fim (desprescrever)



O passo 5 é o mais esquecido: prescrever também é saber a hora de PARAR.

O que o fármaco faz na demência — e o que ele NÃO faz



Encéfalo · J.A. Beal · CC BY 2.5



Sintomático (cognição)

anticolinesterásicos e memantina: benefício MODESTO e temporário; não curam



Modificador (anti-amiloide)

lecanemabe/donanemabe: retardam discretamente; casos selecionados; ARIA



Não-farmacológico é base

estímulo, exercício, social, tratar comorbidade/sensorial



Tratar o que pesa

humor, sono, dor, BPSD — muitas vezes mais impactante

Anticolinesterásicos: leve a moderada (DCL/PDD também) — titular sempre

Fármaco	Faixa usual / dia	Observações
Donepezila	5 mg → 10 mg (1x/dia)	titular após ~4 sem; noite
Rivastigmina	oral 1,5→6 mg 2x; adesivo 4,6→9,5→13,3 mg/24h	adesivo: menos GI
Galantamina	8 → 16 → 24 mg/dia	ER 1x/dia; titular mensal



Princípios

- Indicação: AD leve-moderada; DCL e demência de Parkinson (ótima resposta)
- Efeito modesto; titular para a dose-alvo
- Manter enquanto houver benefício/uso

Faixas usuais; ajustar/monitorizar conforme tolerância, peso e protocolo local.

Os efeitos colinérgicos preveem os cuidados



Adversos comuns

- GI: náusea, vômito, diarreia, anorexia/perda de peso
- Bradicardia, síncope; câibras, sonhos vívidos, insônia



Cautela / contraindicações

- Bradiarritmia/BAV, síncope; DPOC/asma grave
- Úlcera péptica ativa; baixo peso



Monitorizar

- FC e sintomas (síncope/queda); peso
- Reavaliar benefício; suspender se intolerância

Armadilha: anticolinesterásico + anticolinérgico (ex.: oxibutinina) = antagonismo — revise a lista!

Memantina: moderada a grave — boa tolerância, pode combinar

Fármaco	Faixa usual / dia	Observações
Memantina	5 mg → 20 mg/dia (↑5 mg/sem)	ajuste se ClCr baixo
Combinação	memantina + anticolinesterásico	na moderada-grave



Pontos-chave

- Antagonista NMDA; indicação na AD moderada a grave
- Bem tolerada (não-colinérgica): menos GI/bradicardia
- Adversos: tontura, cefaleia, confusão/constipação
- Reduzir dose na insuficiência renal

Faixas usuais; ajuste renal e monitorização conforme protocolo local.

A farmacoterapia muda conforme o tipo de demência



Alzheimer

anticolinesterásico (leve-mod) ± memantina (mod-grave); anti-amiloide selecionado



Corpos de Lewy / Parkinson

anticolinesterásico ajuda (cognição/alucinação); EVITAR antipsicótico típico



Vascular

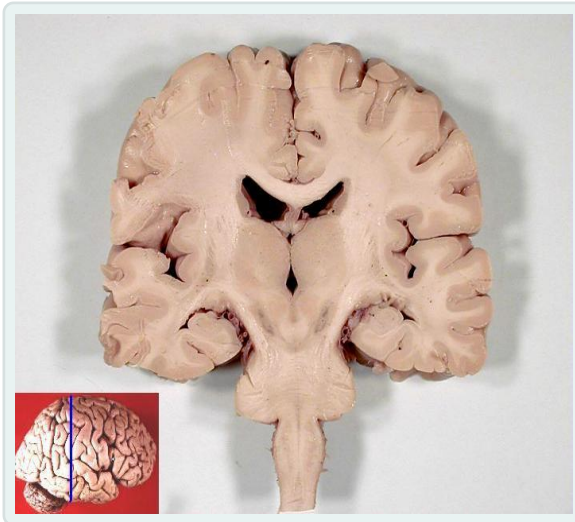
sem fármaco específico: controlar fatores (HAS/DM/lipídios/antiagregação)



Frontotemporal

SEM benefício de anticolinesterásico; foco comportamental (ISRS p/ sintomas)

Lecanemabe e donanemabe: promessa real, indicação estreita, risco de ARIA



Encéfalo (corte) · CC BY 2.5



O que são

anticorpos anti-amiloide IV; lecanemabe (FDA 2023), donanemabe (FDA 2024)



Indicação **ESTREITA**

CCL/demência LEVE por AD, com amiloide confirmado (PET/LCR)



Benefício

retardo MODESTO do declínio (semanas-meses); não reverterem



ARIA (risco)

edema/micro-hemorragia: RM seriada; pior em ApoE4 homozigoto

Realidade: alto custo, infusão e RM seriada, critérios rígidos — acesso limitado (conferir status no Brasil/ANVISA).

Sintomas neuropsiquiátricos: não-farmacológico 1º, fármaco com cautela



Ache o gatilho

dor, delirium/ITU, fármaco, ambiente (DICE) antes de medicar



Se medicar (alvo/risco)

antipsicótico atípico dose baixa, curto; brexpiprazol (agitação na AD)



Humor/ansiedade

ISRS para depressão/ansiedade; evitar benzo de rotina



Segurança

black box (AVC/morte); EVITAR antipsicótico típico no DCL

Detalhe completo na aula “BPSD: sintomas neuropsiquiátricos nas demências”.

Demência avançada: também é hora de simplificar e retirar



Quando rever/retirar

- Sem benefício claro ou efeito adverso
- Demência muito avançada / fim de vida
- Anticolinesterásico: avaliar retirada (monitorar piora)
- Cortar o que não serve à meta (estatina? rígido controle?)



Como desprescrever

- Alinhar metas com paciente/família (proporcionalidade)
- Retirar 1 por vez; reduzir gradual quando indicado
- Monitorar reabstinência/piora e reintroduzir se preciso
- Registrar a decisão

Sr. P., Alzheimer moderado — qual ajuste farmacológico?

Pistas

- Em donepezila 5 mg há 3 meses, tolera bem
- Declínio cognitivo/funcional progredindo
- Sem bradicardia; FC normal
- Família pergunta de “remédio novo que cura”

Conduta

A

Titular donepezila p/ 10 mg; explicar expectativas; considerar memantina na evolução

B

Iniciar lecanemabe imediatamente

C

Suspender tudo — “não adianta”

Resposta: A — otimizar o que há, expectativa realista; anti-amiloide não se aplica (moderado).

Delirium: a melhor “farmacologia” é a PREVENÇÃO (não-farmacológica)



Orientação/cognição

relógio, calendário, óculos/aparelho, presença familiar



Sono

higiene do sono; reduzir ruído/luz à noite; evitar despertares



Mobilidade

mobilizar cedo; evitar contenção e sondas desnecessárias



Hidratação/eliminação

hidratar; tratar constipação/retenção; nutrição



Sensorial/ambiente

corrigir visão/audição; ambiente calmo e familiar

Pacotes multicomponentes (tipo HELP) previnem ~1/3 dos casos — sem nenhum fármaco. (NICE 2023)

Metade do delirium é iatrogênica — corte o gatilho farmacológico



Benzodiazepínicos

precipitam e prolongam — evitar (exceto abstinência)



Opioides

necessários p/ dor, mas titular; preferir não-opioide quando possível



Anticolinérgicos

ADT, anti-H1, oxibutinina, antiespasmódicos



Polifarmácia

revisar TUDO; suspender o não essencial



“Tethers”

sondas, cateteres, contenção, restrição ao leito



Não tratar a causa

ITU, dor, hipóxia, distúrbio metabólico, abstinência

Regra: tratar a CAUSA é o tratamento do delirium — fármaco psicoativo não corrige a causa.

Fármaco no delirium: exceção, para agitação grave com risco



Quando e como

- Só se agitação grave com risco a si/outros ou impede cuidado vital
- Antipsicótico em dose mínima, curtíssimo prazo
- Haloperidol 0,25–0,5 mg; ou atípico (quetiapina/risperidona) baixo
- Reavaliar a cada dose; suspender assim que possível



Exceções e alertas

- Abstinência (álcool/benzo): BENZODIAZEPÍNICO é o tratamento
- DCL/Parkinson: evitar antipsicótico típico (preferir quetiapina baixa)
- CTI: dexmedetomidina pode reduzir delirium/ventilação
- Antipsicótico NÃO encurta o delirium nem previne

Faixas/escolhas dependem de QT, função orgânica e protocolo local — individualize.

Delirium: os erros que prolongam e pioram



Sedar “de horário”

antipsicótico fixo mascara a causa e prolonga



Benzodiazepínico (não-abstinência)

piora confusão e o próprio delirium



Contenção física

aumenta agitação, lesão e imobilidade



Não procurar a causa

ITU, dor, hipóxia, fármaco — a causa É o tratamento



Ignorar sono/ambiente

luz/ruído noturnos perpetuam o quadro



Alta sem revisar fármacos

manter o que causou — recidiva

Sr. P. internado por ITU, ficou confuso e inquieto à noite. Conduta?

Pistas

- Delirium hipoativo-hiperativo, pior à noite
- ITU em tratamento; constipado; sonda vesical
- Recebeu difenidramina “para dormir”
- Sem agressão grave no momento

Conduta

A

Haloperidol fixo 8/8h até a alta

B

Tratar causas: suspender difenidramina, retirar sonda, tratar constipação, sono/ambiente; antipsicótico só se agitação grave

C

Benzodiazepínico à noite para dormir

Resposta: B — causa + não-farmacológico; antipsicótico é exceção (e difenidramina/benzo pioram).

Depressão no idoso: subtratada, tratável — e tratar muda desfecho



Foto ilustrativa · CC0



Quando tratar

episódio depressivo (rastreo +); impacto funcional/sofrimento; risco



Metas

remissão, recuperar funcionalidade e prevenir recorrência/suicídio



Não-farmacológico

psicoterapia, atividade, social, exercício, sono, tratar dor/doenças



Atenção

depressão pode ser pseudodemência OU pródromo de demência — reavaliar

ISRS são a 1ª linha — começar baixo, titular, esperar resposta

Fármaco	Faixa usual / dia	Observações
Sertralina	25 → 50–100 (até 200) mg	boa 1ª escolha; poucas interações
Escitalopram	5 → 10 (máx 10–20) mg	atenção QT em dose alta
Citalopram	≤ 20 mg (idoso) — QT!	limite por prolongamento de QT



Como conduzir

- Resposta em 2–4 sem; efeito pleno 6–12 sem
- Titular se resposta parcial; não desistir cedo
- Manter ≥ 6–12 meses (mais se recorrente)
- Retirar gradual (descontinuação)

Faixas usuais; individualizar (QT, renal/hepático, interações) e monitorizar.

Antidepressivos: evitar uns, vigiar efeitos típicos do idoso



Evitar / cautela

- Tricíclicos (anticolinérgico, cardio, quedas) — Beers
- Paroxetina (anticolinérgica, descontinuação)
- Associações serotoninérgicas (s. serotoninérgica)



Vigiar (todos ISRS)

- Hiponatremia/SIADH (cheçar Na, esp. 1ª sem)
- Sangramento (↑ com AINE/anticoagulante)
- Quedas, QT (citalopram), bradicardia/insônia



Segurança maior

- Risco de SUICÍDIO: avaliar e monitorar
- Reavaliar em 1–2 sem no início
- Encaminhar se grave/refratário/psicótico

Escolher pelo perfil de sintomas e comorbidades

Fármaco	Faixa usual / dia	Observações
Mirtazapina	7,5/15 → 30–45 mg (noite)	insônia + inapetência/perda de peso; pouco sexual
Venlafaxina / Duloxetina	titular (IRSN)	depressão + DOR neuropática; vigiar PA (venla)
Bupropiona	150 → 300 mg	apatia/fadiga; evita disfunção sexual; evitar se convulsão
Trazodona (baixa)	25–50 mg noite	auxílio do SONO (não como antidepressivo isolado)

2ª linha após falha/parcial ao ISRS; combinar com não-farmacológico. Individualizar sempre.

Persistir o suficiente — e escalar quando preciso



Tempo & resposta

aguardar 4–6 sem na dose-alvo antes de julgar; efeito pleno 6–12 sem



Resposta parcial/nula

otimizar dose → trocar de classe → considerar combinação/potencialização



Manutenção

≥ 6–12 meses; recorrente/grave → mais longo; retirar gradual



Grave/refratária/psicótica

encaminhar; ECT é eficaz e segura no idoso (psicótica, risco alto, recusa alimentar)

CASO · BLOCO DEPRESSÃO

Sr. P. com humor rebaixado, insônia e perda de peso. Qual antidepressivo?

Pistas

- Anedonia, insônia, inapetência, -5 kg
- QT no limite superior; usa AAS
- Sem ideação suicida ativa
- Já em donepezila

Escolha

A

Amitriptilina (ADT) à noite

B

Mirtazapina à noite (insônia + ganho de apetite); ou sertralina; evitar citalopram alto (QT)

C

Citalopram 40 mg

Resposta: B — perfil (insônia/perda de peso) favorece mirtazapina; ADT e citalopram alto são inadequados.

Quatro vigilâncias que valem para tudo no idoso



QT longo

citalopram, antipsicóticos, alguns; checar ECG/eletrolitos se risco



Hiponatremia

ISRS (SIADH); checar Na; náusea/confusão = alerta



Quedas/sedação

psicotrópicos, anticolinérgicos, benzo; revisar a cada queda



Interações

serotoninérgica, sangramento (ISRS+AINE/anticoag), CYP, anticolinérgica somada

Reconcilie a medicação a cada transição de cuidado (internação/alta).

Saber retirar é tão importante quanto saber iniciar



Enfermeira e idoso · domínio público (DOCUMERICA)



Demência

reavaliar anticolinesterásico/memantina no avançado; cortar o que não serve à meta



Delirium

retirar precipitantes; suspender o antipsicótico iniciado na crise (não cronificar)



Depressão

manter o tempo certo; retirar GRADUAL (descontinuação); revisar após remissão



Sempre

menos é mais: 1 por vez, metas com a família, registrar e monitorar

O erro nº 1: somar fármaco em vez de tratar a causa e revisar a lista



A armadilha

Cascata: tratar efeito adverso com novo fármaco (ex.: oxibutinina → confusão → antipsicótico → quedas).



Como evitar

- “Este sintoma é doença ou é remédio?”
- Reconciliar e revisar a lista a cada consulta
- Ciclo completo: até o passo de desprescrever



Curiosidade: a melhor intervenção farmacológica do idoso muitas vezes é RETIRAR um fármaco — desprescrever melhora cognição, quedas e mortalidade em estudos de polifarmácia.

Farmacoterapia das 3 condições em uma régua

Indicação → Escolha → Dose (start low, go slow) → Monitorizar → Reavaliar/DESPRESCREVER



Demência

anticolinesterásico (leve-mod) ± memantina (mod-grave); anti-amiloide é exceção; trate humor/dor.



Delirium

prevenir > medicar; tratar a causa; fármaco só p/ agitação grave; benzo só na abstinência.



Depressão

ISRS 1ª linha; perfil define 2ª; evitar ADT/paroxetina e citalopram alto (QT).

Teste rápido: Q1 a Q3

Q1

Alzheimer leve-moderada, FC normal. 1ª linha farmacológica?

A) Memantina B) Anticolinesterásico (ex.: donepezila) C) Antipsicótico D) ADT

Q2

Idoso com delirium por ITU, agitado mas sem risco grave. Conduta?

A) Haloperidol fixo B) Tratar causa + não-farm; antipsicótico só se grave C) Benzo D) Difenidramina

Q3

Depressão no idoso. Qual EVITAR?

A) Sertralina B) Mirtazapina C) Amitriptilina (ADT) D) Escitalopram

Pense antes de virar o slide — gabarito comentado a seguir.

Mais três e os comentários

Q4. Dose máxima de citalopram no idoso (QT)?

Q5. Delirium por abstinência alcoólica: fármaco?

Q6. Anti-amiloide (lecanemabe): principal risco a monitorar?

Gabarito comentado

Q1 → B — Anticolinesterásico é 1ª linha na AD leve-moderada (e DCL/PDD).

Q2 → B — Causa + não-farm; antipsicótico só se agitação grave/risco.

Q3 → C — ADT: anticolinérgico, cardiotoxico, quedas (Beers).

Q4 → 20 mg — Limite por prolongamento de QT no idoso.

Q5 → Benzo — Exceção: abstinência álcool/benzo é tratada com benzo.

Q6 → ARIA — Edema/micro-hemorragia; exige RM seriada.

Recapitule agora — e revise nos próximos dias

Em 30 segundos, recupere de memória:

- A régua (indicação→...→desprescrever)
- 1ª linha de cada condição
- 3 fármacos a EVITAR no idoso
- Quando o fármaco é exceção (delirium)



3 perguntas para revisar em D+2 e D+7

1. Como titular donepezila e memantina?
2. Por que evitar benzo no delirium (e a exceção)?
3. Qual ISRS escolher por perfil — e o que evitar?

REFERÊNCIAS (VANCOUVER)

Referências

1. American Geriatrics Society. AGS Beers Criteria 2023. J Am Geriatr Soc. 2023.
2. O'Mahony D, et al. STOPP/START (critérios de prescrição no idoso).
3. Academia Brasileira de Neurologia (Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento). Recomendações 2022 (tratamento da DA).
4. van Dyck CH, et al. Lecanemab (Clarity AD). N Engl J Med. 2023. · FDA, aprovação 2023.
5. Sims JR, et al. Donanemab (TRAILBLAZER-ALZ 2). JAMA. 2023. · FDA, aprovação 2024.
6. NICE. Delirium: prevention, diagnosis and management (NG103, atualização 2023).
7. Inouye SK, et al. Delirium in elderly people. Lancet. 2014. · HELP (programa multicomponente).
8. Porsteinsson AP, et al. CitAD (citalopram/agitação). JAMA. 2014. · FDA QT alert (citalopram).
9. APA / diretrizes de depressão geriátrica; ISRS 1ª linha; evitar ADT/paroxetina (Beers).
10. Lecanemab/donanemab — bula e monitorização de ARIA (RM seriada); status ANVISA a conferir.

Doses = faixas usuais; conferir bula, função orgânica, interações, QT e protocolo local.

CRÉDITOS

Créditos de imagens e nota de marca

Imagens (licença livre / domínio público — Wikimedia Commons):

- Encéfalo humano (J. A. Beal) — CC BY 2.5 · Idoso (Brasil) — Adam Jones — CC BY-SA
- Idoso sentado — jaocampo — CC0 · Enfermeira e idoso (DOCUMERICA) — domínio público

Ícones: Font Awesome. **Tabelas de dose, diagramas e esquemas:** originais desta aula.



Marca institucional: logo oficial da CMMG / FELUMA na capa e banner no encerramento, de uso institucional. Paleta FCMMG.

Obrigado!

Indicação → Escolha → Dose → Monitorizar → **Desprescrever.**

Prof. Dr. Igor Moraes · CRM-MG 76695 (RQE Geriatria 66254) · Saúde do Idoso — FCMMG

